



GUIA PARA PACIENTES

Cotovelo de tenista, sem jogar tênis

o que a ciência diz sobre a epicondilite lateral e o que você pode fazer em casa

Por que o cotovelo dói ao pegar e apertar objetos, por que a maioria melhora com o tempo e por que a infiltração nem sempre é o atalho que parece.



**DR. ROBERTO
RODRIGUES**
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
CIRURGIA DO JOELHO

CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765 · @robertorodriguesmd

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Palavra-chave no Instagram: **COTOVELO**

Para quem é:

Para quem sente dor na **parte de fora do cotovelo**, que piora ao **pegar, apertar ou torcer** (abrir um pote, torcer um pano, levantar uma xícara com o braço esticado, usar o mouse ou uma ferramenta), **sem queda ou batida e sem nenhum sinal de alerta da próxima página**.

Para quem NÃO é:

- Quem tem algum sinal de alerta da Página 3.
- Quem tem dor na **parte de dentro** do cotovelo ou formigamento nos dedos: costuma ser outro problema (opinião clínica).
- Quem operou o cotovelo recentemente: siga a orientação da sua equipe.
- Crianças e adolescentes com dor no cotovelo, principalmente atletas: precisam de avaliação antes de qualquer exercício (opinião clínica).

O que você vai precisar:

- Uma mesa e uma cadeira.
- Uma garrafinha de água de 500 ml e, depois, uma de 1 litro.
- Um martelo comum ou um objeto parecido, com cabo.
- Uma caneta para o rastreador da Página 9.

Regra de ouro:

Exercício com **incômodo leve**: sim. Dor que **aumenta a cada repetição** ou que **deixa o cotovelo pior no dia seguinte**: não. A regra completa está na Página 7.

A maioria das dores na parte de fora do cotovelo não é grave. Mas existe uma minoria que é, e ela tem sinais. **Leia esta página antes de qualquer outra.**

Ligue 192 (SAMU) ou vá ao pronto-socorro AGORA se:

- A dor no braço vem com **aperto ou peso no peito, falta de ar, suor frio ou enjoo. Pode ser o coração:** a dor de origem cardíaca pode aparecer no braço, no ombro, no pescoço e na mandíbula [1].

Procure atendimento HOJE se:

- Depois de **queda ou trauma**, o cotovelo **inchou rápido**, ficou **deformado** ou você **não consegue dobrar ou esticar** o braço.
- O cotovelo está **quente, vermelho e inchado**, com **febre** ou calafrios.

Procure avaliação em poucos dias se:

- Há **dormência, formigamento ou fraqueza** na mão, ou dificuldade nova para **esticar os dedos**.
- A dor **começa no pescoço** e desce pelo braço. Dor no pescoço junto com a do cotovelo muda a forma de tratar [2].
- O cotovelo **trava** ou "prende" ao mexer.
- A dor é **constante, inclusive em repouso e à noite**, ou você está **perdendo peso sem querer** ou já teve **câncer**.

Os itens desta página, exceto o do coração e o do pescoço, são orientação de bom senso clínico (opinião clínica).

Observação honesta: nenhum desses sinais, sozinho, prova doença grave. Eles servem para dizer **quem precisa ser examinado antes**.

Um tendão que perdeu a tolerância à carga

Os músculos que **esticam o punho e os dedos** se prendem, por tendões, num pequeno relevo do osso na parte de fora do cotovelo, chamado **epicôndilo lateral**. Quando esse tendão fica sensível, cada vez que você aperta ou levanta algo com o punho firme, ele reclama.

O nome técnico é **epicondilite lateral**. O "-ite" sugere só inflamação, mas o quadro envolve **alterações no próprio tendão**, mudanças no **controle do movimento** e na forma como o corpo **processa a dor** [4]. Por isso, muitos especialistas preferem o nome **tendinopatia lateral do cotovelo**.

Quem tem

O nome veio do tênis, mas o problema é **comum na população geral**. Num estudo com a população adulta da Finlândia, cerca de **1 em cada 77 adultos** tinha o quadro naquele momento, com pico entre **45 e 54 anos**. A **combinação de movimento repetitivo com força** nos braços aumentou bastante o risco [3].

Na prática do consultório, aparece em quem carrega sacolas, usa ferramentas, digita ou usa o mouse por horas, cuida de bebê no colo ou faz faxina pesada (opinião clínica).

O sinal típico

Dor na parte de fora do cotovelo ao **apertar a mão de alguém, levantar uma cadeira** ou **segurar uma xícara com o braço esticado**.

O curso natural costuma ser favorável

Uma revisão juntou os grupos de **placebo ou sem tratamento** de vários estudos. Cerca de **9 em cada 10 pessoas** tiveram melhora global em **1 ano**, e metade dessa melhora aconteceu nos primeiros **2,5 a 3 meses** [5].

Num estudo holandês com 185 pessoas, **83%** de quem apenas recebeu orientação e aguardou estavam bem em 1 ano [6].

O tempo de dor não decide o futuro

Na mesma revisão, **há quanto tempo a pessoa sentia dor** não mudou a chance de melhorar [5]. Ter dor há meses **não significa** que o caso "cronificou" nem que agora só resta a cirurgia.

Mas não é garantia

Uma parte das pessoas continua com dor além de 1 ano, e o problema pode voltar: num estudo americano, cerca de **8,5%** tiveram nova crise em até 2 anos [7].

"Esperar" não é ficar parado

Esperar, nos estudos, significava receber **orientação** e seguir a vida com **ajuste das atividades** [6]. É isso que as próximas páginas organizam: proteger o tendão sem desligar o braço e dar a ele carga na medida certa.

A pergunta certa não é "o que faz sumir rápido?", e sim "o que ajuda sem atrapalhar a melhora que o corpo já tende a fazer?".

Três estudos compararam esses caminhos:

- **Holanda, 185 pessoas:** na 6ª semana, a infiltração de corticoide ganhou. Em **1 ano**, o quadro inverteu: sucesso em **69%** com infiltração, **91%** com fisioterapia e **83%** só aguardando [6].
- **Austrália, 198 pessoas:** a fisioterapia (exercício e mobilização) superou a espera nas primeiras 6 semanas; em 1 ano, **não houve diferença**. Na infiltração, **47 de 65** pessoas que tinham melhorado voltaram a piorar [8].
- **Austrália, 165 pessoas:** em 1 ano, quem recebeu corticoide teve **menos recuperação** (83% contra 96% do placebo) e **mais recaída** (54% contra 12%) [9].

Em resumo: a infiltração alivia rápido, mas pode **cobrar o preço depois**. A fisioterapia ajuda a melhorar mais cedo, mas em 1 ano a vantagem sobre aguardar com orientação foi pequena ou nenhuma [6][8][9].

E o PRP (plasma rico em plaquetas)?

A evidência é **conflitante**. Um estudo com 230 pessoas mostrou vantagem em 24 semanas sobre agulhamento sem PRP [11]. Uma revisão Cochrane com 32 estudos e 2.337 pessoas concluiu que o PRP **provavelmente não traz melhora relevante** em relação a uma injeção placebo [10]. Por isso, não indico como tratamento de rotina (opinião clínica).

Este guia não indica remédio, injeção nem dose. Isso é decisão da consulta.

Ajuste de carga no dia a dia e no trabalho

Orientações práticas, coerentes com a ligação entre esforço repetitivo com força e o problema [3] (opinião clínica):

- Pegue objetos com a **palma para cima** e o cotovelo **dobrado, perto do corpo**.
- **Divida o peso**: duas mãos, sacolas menores.
- Em tarefa repetitiva, **pausas** a cada 30 a 45 minutos e, se der, **alterne as mãos**.
- Mouse e teclado na **altura do cotovelo**, punho reto; ferramentas com **cabo mais grosso**.

A faixa de contraforça (órtese)

É a tira presa logo **abaixo** do cotovelo. Uma revisão Cochrane **não chegou a conclusão definitiva** [12]. Um estudo pequeno, com 31 pessoas, mostrou menos dor nas primeiras semanas do que com uma faixa placebo [13]. Pode ajudar nas tarefas que doem. **Não substitui o exercício** e não deve apertar a ponto de formigar.

Semáforo da dor (0 = sem dor; 10 = a pior imaginável)

- **Verde (0 a 3)**: continue e, com os dias, progrida.
- **Amarelo (4 a 5)**: aceitável **se** voltar ao seu normal até a manhã seguinte. Não progrida.
- **Vermelho (acima de 5)** ou pior no dia seguinte: reduza carga ou repetições.

Os números do semáforo são orientação prática de consultório, não testados exatamente assim em estudo.

Exercício supera tratamentos passivos, com efeito pequeno e evidência de baixa certeza [16]. A escolha destes três é opinião clínica.

Exercício 1 — Isometria de extensão do punho

Como fazer: sentado, antebraço apoiado na mesa, **palma para baixo**, mão para fora da borda. Com a outra mão sobre o dorso, empurre para cima **sem o punho se mover**, com força leve a moderada. Segure 30 a 45 segundos. 5 vezes.

Sensação correta: esforço no antebraço, dor no verde ou no amarelo.

Erro comum: força máxima ou prender a respiração.

Exercício 2 — Descida lenta do punho (excêntrico)

Como fazer: mesma posição, segurando a garrafinha. Use a **outra mão para subir** o punho e **desça sozinho, contando 3 a 4 segundos**. 3 séries de 10 a 15.

Sensação correta: cansaço controlado no fim da série.

Erro comum: subir com o braço doente ou deixar o peso "cair".

Exercício 3 — Giro do antebraço com martelo

Como fazer: cotovelo dobrado e apoiado, segure o martelo **perto da cabeça**. Gire devagar, palma para cima e para baixo. 3 séries de 10. Para progredir, segure mais longe da cabeça.

Sensação correta: esforço sem fisgada.

Erro comum: girar com o ombro.

De onde vem: a isometria superou a espera em 8 semanas, mas sozinha pode não bastar [14]; o excêntrico entra como **parte** de um programa [15].

Semanas 1 e 2 — Acalmar

- **Exercício 1** todos os dias, 1 a 2 vezes.
- Ajuste de carga da Página 7 em casa e no trabalho.

Semanas 3 e 4 — Começar a carregar

- **Exercício 1** todos os dias.
- **Exercício 2** em dias alternados, se o Exercício 1 ficou no verde ou no amarelo.

Semanas 5 e 6 — Progredir

- **Exercícios 1, 2 e 3** em dias alternados (por exemplo: segunda, quarta e sexta).
- Progrida **uma coisa de cada vez**: mais repetições **ou** garrafa de 1 litro **ou** martelo segurado mais longe.

Volumes e prazos são ponto de partida prático, não protocolo testado. O estudo de isometria usou 8 semanas [14]. A melhora do tendão leva semanas a meses [5].

Rastreador

	Dor ao acordar (0–10)	Dor máx. no exercício (0–10)	Dor ao pegar uma xícara (0–10)	Dias de exercício na semana (0–7)
Semana 1				
Semana 2				
Semana 3				
Semana 4				
Semana 5				
Semana 6				

Leve esta tabela para a consulta. Ela mostra ao médico a tendência, e não só o pior dia.

1. Imobilizar o braço "até passar".

Repouso total tende a deixar o tendão ainda menos tolerante à carga (opinião clínica). Ajuste de carga, sim; desligar o braço, não.

2. Ver a infiltração como solução rápida.

Ela alivia nas primeiras semanas, mas em 1 ano os resultados foram piores e as recaídas mais frequentes do que sem ela [6][8][9]. Se for considerada, deve ser uma decisão conversada, sabendo disso.

3. Achar que a faixa resolve sozinha.

A evidência sobre a órtese é limitada [12][13]. Ela pode aliviar tarefas; quem trata é a carga progressiva.

4. Forçar no pico da dor.

Peso alto, alongamento forte e "aguentar firme" costumam piorar o quadro. Use o semáforo da Página 7.

5. Decidir pelo calendário: "faz 6 meses, então tem de operar".

O tempo de dor não previu quem melhoraria [5]. A decisão depende da avaliação, e não só do calendário.

Bônus: pedir exame de imagem antes de tudo.

O diagnóstico costuma ser feito pela história e pelo exame físico. O exame é pedido quando vai mudar a conduta ou quando há dúvida (opinião clínica).

Procure avaliação se:

- Não há **melhora clara após 6 a 8 semanas** de exercício bem feito (opinião clínica).
- A dor **piora** ou atrapalha o **sono**, o **trabalho** ou cuidar de si.
- Surgiu **formigamento, dormência ou fraqueza** na mão.
- **A qualquer momento**: apareceu algum sinal da Página 3.

E a cirurgia?

É **exceção**. Num estudo americano de base populacional, só **1% a 3%** dos casos foram operados em até 2 anos [7]. Num estudo pequeno (26 pessoas), a cirurgia **não superou uma cirurgia placebo** [17], e a revisão Cochrane não encontrou evidência suficiente nem a favor nem contra [18]. Em casos selecionados, que persistem apesar de tratamento bem feito, ela pode ser discutida.

Se quiser uma avaliação

A consulta começa por **história e exame físico** do cotovelo, do punho e do pescoço. Depois se decide se há necessidade de exame e qual é o tratamento. Quando o caso pede um **cirurgião de mão e cotovelo**, o encaminhamento faz parte do cuidado.

Agendamento: agendar.drrobertorodrigues.com

Instagram: @robertorodriguesmd

Atendimento em Fortaleza (CE).

Material educativo. Não substitui consulta médica. Nenhum tratamento tem resultado garantido. Cada caso precisa de avaliação individual.

1. Gulati M, Levy PD, Mukherjee D, Amsterdam E, et al. **2021 AHA/ACC/ASE/CHEST/SAEM/SCCT/SCMR Guideline for the Evaluation and Diagnosis of Chest Pain.** *Circulation.* 2021;144(22):e368-e454. doi:10.1161/CIR.0000000000001029. PMID: 34709879.
2. Coombes BK, Bisset L, Vicenzino B. **Management of lateral elbow tendinopathy: one size does not fit all.** *J Orthop Sports Phys Ther.* 2015;45(11):938-949. doi:10.2519/jospt.2015.5841. PMID: 26381484.
3. Shiri R, Viikari-Juntura E, Varonen H, Heliövaara M. **Prevalence and determinants of lateral and medial epicondylitis: a population study.** *Am J Epidemiol.* 2006;164(11):1065-1074. doi:10.1093/aje/kwj325. PMID: 16968862.
4. Lucado AM, Day JM, Vincent JI, MacDermid JC, Fedorczyk J, Grewal R, et al. **Lateral elbow pain and muscle function impairments.** *J Orthop Sports Phys Ther.* 2022;52(12):CPG1-CPG11. doi:10.2519/jospt.2022.0302. PMID: 36453071.
5. Ikonen J, Lähdeoja T, Ardern CL, Buchbinder R, Reito A, Karjalainen T. **Persistent tennis elbow symptoms have little prognostic value: a systematic review and meta-analysis.** *Clin Orthop Relat Res.* 2022;480(4):647-660. doi:10.1097/CORR.0000000000002058. PMID: 34874323.
6. Smidt N, van der Windt DA, Assendelft WJ, et al. **Corticosteroid injections, physiotherapy, or a wait-and-see policy for lateral epicondylitis: a randomised controlled trial.** *Lancet.* 2002;359(9307):657-662. doi:10.1016/S0140-6736(02)07811-X. PMID: 11879861.
7. Sanders TL Jr, Maradit Kremers H, Bryan AJ, Ransom JE, Smith J, Morrey BF. **The epidemiology and health care burden of tennis elbow: a population-based study.** *Am J Sports Med.* 2015;43(5):1066-1071. doi:10.1177/0363546514568087. PMID: 25656546.
8. Bisset L, Beller E, Jull G, Brooks P, Darnell R, Vicenzino B. **Mobilisation with movement and exercise, corticosteroid injection, or wait and see for tennis elbow: randomised trial.** *BMJ.* 2006;333(7575):939. doi:10.1136/bmj.38961.584653.AE. PMID: 17012266.
9. Coombes BK, Bisset L, Brooks P, Khan A, Vicenzino B. **Effect of corticosteroid injection, physiotherapy, or both on clinical outcomes in patients with unilateral lateral epicondylalgia: a randomized controlled trial.** *JAMA.* 2013;309(5):461-469. doi:10.1001/jama.2013.129. PMID: 23385272.
10. Karjalainen TV, Silagy M, O'Bryan E, Johnston RV, Cyril S, Buchbinder R. **Autologous blood and platelet-rich plasma injection therapy for lateral elbow pain.** *Cochrane Database Syst Rev.* 2021;9(9):CD010951. doi:10.1002/14651858.CD010951.pub2. PMID: 34590307.
11. Mishra AK, Skrepnik NV, Edwards SG, Jones GL, Sampson S, Vermillion DA, et al. **Efficacy of platelet-rich plasma for chronic tennis elbow: a double-blind, prospective, multicenter, randomized controlled trial of 230 patients.** *Am J Sports Med.* 2014;42(2):463-471. doi:10.1177/0363546513494359. PMID: 23825183.
12. Struijs PA, Smidt N, Arola H, van Dijk CN, Buchbinder R, Assendelft WJ. **Orthotic devices for the treatment of tennis elbow.** *Cochrane Database Syst Rev.* 2002;(1):CD001821. doi:10.1002/14651858.CD001821. PMID: 11869609.
13. Krosiak M, Pirapakaran K, Murrell GAC. **Counterforce bracing of lateral epicondylitis: a prospective, randomized, double-blinded, placebo-controlled clinical trial.** *J Shoulder Elbow Surg.* 2019;28(2):288-295. doi:10.1016/j.jse.2018.10.002. PMID: 30658774.
14. Vuvan V, Vicenzino B, Mellor R, Heales LJ, Coombes BK. **Unsupervised isometric exercise versus wait-and-see for lateral elbow tendinopathy.** *Med Sci Sports Exerc.* 2020;52(2):287-295. doi:10.1249/MSS.0000000000002128. PMID: 31425384.
15. Cullinane FL, Boockock MG, Trevelyan FC. **Is eccentric exercise an effective treatment for lateral epicondylitis? A systematic review.** *Clin Rehabil.* 2014;28(1):3-19. doi:10.1177/0269215513491974. PMID: 23881334.
16. Karanasios S, Korakakis V, Whiteley R, Vasileogeorgis I, Woodbridge S, Giffossos G. **Exercise interventions in lateral elbow tendinopathy have better outcomes than passive interventions, but the effects are small: a systematic review and meta-analysis of 2123 subjects in 30 trials.** *Br J Sports Med.* 2021;55(9):477-485. doi:10.1136/bjsports-2020-102525. PMID: 33148599.
17. Krosiak M, Murrell GAC. **Surgical treatment of lateral epicondylitis: a prospective, randomized, double-blinded, placebo-controlled clinical trial.** *Am J Sports Med.* 2018;46(5):1106-1113. doi:10.1177/0363546517753385. PMID: 29498885.
18. Buchbinder R, Johnston RV, Barnsley L, Assendelft WJ, Bell SN, Smidt N. **Surgery for lateral elbow pain.** *Cochrane Database Syst Rev.* 2011;(3):CD003525. doi:10.1002/14651858.CD003525.pub2. PMID: 21412883.

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Dr. Roberto Rodrigues · CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765